

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Otoplasty / Repair of Prominent Ears

معلومات الإقرار – نسخة المريض تجميل الأذن \ إصلاح الأذن البارزة

1. What do I need to know about this procedure?

A cut is usually made behind the ear in order to do the operation. Further cuts may be made by some surgeons.

A number of techniques and stitches can be used to reshape the cartilage, to remove excess cartilage and to correct ears that stick out too much.

The appearance of the ear will depend upon its initial size and shape. The healing process after the operation will also be a factor and will largely dictate the degree of normality of this operation. Perfect symmetry between the two ears cannot be guaranteed.

The post-operative pain is normally minimal after 24-48 hours. If pain persists the surgeon should be consulted, as this may be an early sign of complications developing.

To be able to reduce the risk of fluid collecting under the skin, a fairly bulky and tight bandage will be used which needs to be kept in place for one to two weeks.

There may be some oozing after surgery. This may be seen on the outside of the bandage. Provided this does not get worse, it should not cause problems.

The cut/s normally heals with only a small scar behind the ear/s. Usually the result is excellent and because of its location the scar cannot be seen.

The length of hospital stay varies and may range from a day only short stay to about two days in hospital as long as there are no complications.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

1- ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

للقيام بالعملية ، يتم عمل شق جراحي خلف الأذن . قد يقوم بعض الجراحين بعمل شقوق جراحية أخرى.

هناك العديد من الأساليب والغرز الجراحية التي يمكن استخدامها لإعادة تشكيل الغضروف ، لإزالة فائض الغضروف وإصلاح الأذن التي تبرز للخارج بشكل مبالغ فيه.

تتوقف الصورة التي سوف تظهر عليها الأذن على حجمها وشكلها الأصليين . عملية التئام الجرح بعد العملية هو أيضاً عامل مهم ويلعب دوراً كبيراً في تحديد درجة نجاح العملية في إعطاء الأذن شكلها الطبيعي والسوي.

لا يمكن ضمان التماثل التام في شكل الأذنين.

الألم بعد العملية غالباً ما يكون خفيفاً ويستمر 24-48 ساعة. إذا استمر الألم فيجب إبلاغ الجراح ، لأن استمراره قد يكون علامة مبكرة على وجود مضاعفات.

للتمكن من تقليل مخاطر تجمع السوائل تحت الجلد ، يوضع ضماد مشدود وكبير إلى حد ما ويجب بقاء هذا الضماد في مكانه لأسبوع أو أسبوعين.

قد يكون هناك بعض التسرب (الرشح) بعد الجراحة. قد يلاحظ ذلك خارج الضماد . لا ينبغي أن يسبب ذلك أي قلق أو مشكلة طالما أنه لا يتفاقم أو يزداد.

الشق أو الشقوق الجراحية تلتئم بشكل طبيعي مخلفة ندب صغير خلف الأذن/الأذنين. غالباً ما تكون النتيجة ممتازة ، وبسبب موقع هذه الندوب فإنه لا يمكن ملاحظتها أو رؤيتها.

تتفاوت فترة البقاء في المستشفى وقد تتراوح ما بين يوم إلى يومين طالما أنه لا توجد أي مضاعفات.

2-التخدير الذي ألتقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ ورقة معلومات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure are possible.

Specific risks:

- Perfect symmetry between the two ears cannot be guaranteed.
- Discomfort particularly in hot weather, due to bulky and a tight bandage kept in place for one to two weeks.
- Bleeding causing a collection of blood between the skin and the cartilage of the ear.
- Immediate post-operative bleeding, which may require urgent surgery to remove any clot that has formed, and prevent further bleeding.
- Any trauma to the ear after the bandages are removed may cause bleeding and this may need further surgery.
- The ears will look a little swollen and bruised when the bandages are first removed.
- Numbness and abnormality in the feeling of

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3- ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- الوفاة أو حدوث ضرر للمخ محتمل كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة :

- لا يمكن ضمان التماثل التام في شكل الأذنين.
- الشعور بعد الارتياح خاصة في الأجواء الحارة بسبب بقاء الضماد الكبير المشدود في مكانه لأسبوع أو أسبوعين.
- نزيف يؤدي إلى تراكم الدم بين الجلد وغضروف الأذن.
- نزيف يحدث مباشرة بعد العملية مما قد يتطلب جراحة طارئة لإزالة أي تخثر دموي متكوّن ولمنع المزيد من النزيف.
- حدوث أي إصابة للأذن بعد نزع الضماد قد يسبب نزيف مما قد يتطلب إجراء جراحة أخرى.
- تظهر الأذنين متورمة بعض الشيء وبها كدمات للوهلة الأولى بعد نزع الضماد.
- وجود خدر و تغير غير طبيعي في حاسة اللمس على جلد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

touch over the skin of the ear. It should generally return over the next few months.

- Infection, which can cause severe damage and deformity to the ear cartilage. This may prevent adequate wound healing and require further surgery and may reduce the quality of the result.
- The wound may not heal properly and become thickened, red, itchy and swollen. This may require further treatment.
- A second operation to correct residual lopsidedness or irregularity may also be needed. Improvement is the aim. Perfection is not always possible. Further operations may be required to improve the result, particularly if complications as mentioned above arise.

Notes to talk to my doctor about:

الأذن . بشكل عام ، من المفترض أن يعود ذلك لوضعه الطبيعي خلال الأشهر القليلة التي تعقب الجراحة.

- عدوى قد تسبب ضرر شديد وتشوه لغضروف الأذن. قد يمنع ذلك الالتئام الكافي للجرح ويتطلب جراحة أخرى وقد يقلل من جودة النتائج.

- قد لا يلتئم الجرح بشكل صحيح وقد يصبح سميكاً ، أحمر اللون ، مسبباً للحكة ومتورم. قد يتطلب ذلك معالجة أخرى.

- قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لتصحيح أي عدم توازن أو عدم انتظام باق بعد الجراحة الأولى. إن التحسين هو الهدف من الجراحة. الكمال لا يمكن الوصول إليه دائماً. قد تكون هناك حاجة لعمليات أخرى لتحسين النتائج خاصة عند ظهور المضاعفات كما ذكر سابقاً.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
